· 中医中药 ·

深刺纳阳针法联合言语康复对卒中后失语的疗效及对认知功能的影响

徐林莉 *

天津市中医药大学附属南开区中医医院针灸脑病科，天津 300000

[摘要] **目的** 探析深刺纳阳针法联合言语康复训练对卒中后失语的治疗价值。**方法** 选取于天津市中医药大学附属南开区中医医院 2024 年 1 月至 2025 年 1 月诊治的 96 例卒中后失语患者（均为运动性失语）开展随机分组。对照组 48 例施以言语康复训练，试验组 48 例施以深刺纳阳针法联合言语康复训练。对其治疗后的病情相关评分，总体疗效，认知功能及不良反应予以比较。**结果** 4 周疗程结束后，汉语失语成套评定量表（ABC）、功能性语言沟通能力检查法（CFCP）评分试验组较对照组高；总有效率试验组（93.75%）较对照组（77.08%）高；简易智能精神状态检查量表（MMSE）、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）评分试验组较对照组高（$P < 0.05$）。不良反应发生率试验组为 8.33%，对照组为 4.17%，两组差异不明显（$P > 0.05$）。**结论** 深刺纳阳针法联合言语康复训练对卒中后失语有确切效果，患者病情恢复良好、可促进认知功能改善，并具有较高安全性。

[关键词] 脑卒中；失语；言语康复训练；深刺纳阳针法；认知功能

中图分类号：R743.3 文献标识码：A **doi**：10.3969/j.issn.1006-5571.2025.05.016

The efficacy of deep puncture and speech rehabilitation combined with speech rehabilitation training on aphasia after stroke and its effect on cognitive function

*Xu Linli**

Department of Acupuncture and Encephalopathy，Nankai District Hospital of Traditional Chinese Medicine，Tianjin University of Traditional Chinese Medicine，Tianjin 300000，China

[Abstract] Objective To explore the therapeutic value of deep puncture Nayang acupuncture combined with speech rehabilitation training on aphasia after stroke. **Methods** A total of 96 patients with post-stroke aphasia（all motor aphasia）who were diagnosed and treated in Nankai District Hospital of Traditional Chinese Medicine，Tianjin University of Traditional Chinese Medicine from Jan 2024 to Jan 2025 were selected and randomly divided into two groups. The control group （48 cases） was given speech rehabilitation training，and the experimental group（48 cases）was given deep puncture Nayang acupuncture combined with speech rehabilitation training. The disease-related scores，overall efficacy，cognitive function and adverse reactions after treatment were compared. **Results** At the end of the 4-week course of treatment，the scores of Chinese Aphasia Rating Scale（ABC）and Functional Language Communication Proficiency Test（CFCP）in the experimental group were higher than those in the control group. The total effective rate of the experimental group（93.75%） was higher than that of the control group （77.08%）. The scores of the Mini-Mental State Examination（MMSE）and Montreal Cognitive

基金项目：2025 年国家中医药传承创新发展示范试点项目（30299）

通讯作者：徐林莉，邮箱：18202281900@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

Assessment Scale（MoCA）were higher in the experimental group than those in the control group（all $P<0.05$）. There was no significant difference in the incidence of adverse reactions between the experimental group（8.33%）and the control group（4.17%）（$P>0.05$）. **Conclusion** Deep puncture and speech rehabilitation combined with speech rehabilitation have a definite effect on aphasia after stroke, with good recovery of the patient's condition, can promote the improvement of cognitive function, and have a high safety profile.

[Key words] stroke; aphasia; speech rehabilitation training; deep prick Nayang acupuncture; cognitive function

卒中后失语作为一种获得性语言障碍，在临床中较为高发，有数据显示，首次卒中患者失语发生率为32%[1]。卒中后失语对患者表达、阅读、书写等功能造成损害，还会影响认知功能，有必要妥善干预。言语康复训练基于神经可塑性理论，在卒中后失语治疗中有积极作用，但也存在过程枯燥、个体差异大等缺陷。近年来，有报道发现，中医针刺治疗卒中后失语有确切效果[2-3]。可考虑在言语康复训练基础上结合针刺治疗。中医认为，卒中后失语的发生主要与患者阳气亏虚、窍道不通、舌络失养、舌体失用有关。全国优秀中医临床人才张智龙教授（博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国首届百名杰出青年中医）将《难经》、《内经》中的“从阴引阳，从阳引阴”理论与自身临床经验相结合，首创出深刺纳阳针法[4]。其具有深纳阳气，疏利阴分之作用，有助于温煦窍道，疏通舌络，以复喉舌之功能。本研究将深刺纳阳针法与言语康复训练相结合，分析其对卒中后失语的治疗效果及认知功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2024年1月至2025年1月，在天津市中医药大学附属南开区中医医院诊治的96例卒中后失语患者，通过随机数字表法，将患者分为两组。各组均48例，对照组中女21例，男27例；卒中类型：缺血性41例，出血性7例；受教育年限5～16年，平均（9.81±1.73）年；体质量指数20～28 kg/m^2，平均（23.19±1.54）kg/m^2；失语病程27～84天，平均（49.35±11.62）天；年龄45～73岁，平均（60.81±7.35）岁。试验组中女18例，男30例；卒中类型：缺血性39例，出血性9例；受教育年限6～18年，平均（10.25±1.79）年；体质量指数19～27 kg/m^2，平均（23.06±1.58）kg/m^2；失语病程30～81天，平均（48.62±11.37）天；年龄46～75岁，平均（61.39±7.24）岁。经比较，两组数据有可比性，P均>0.05。

纳入标准：（1）符合脑卒中诊断标准[5-6]；（2）首次发病，处于恢复期；（3）年龄45～75岁；（4）符合运动性失语症诊断标准[7]；（5）右利手；（6）生命体征稳定、意识、智力、精神正常；（7）母语为汉语；（8）已于知情同意书签字。

排除标准：（1）伴有皮肤疾病或创伤；（2）其他原因所造成的语言功能障碍；（3）伴有严重感染；（4）心、肾、肺等脏器功能不全；（5）脑卒中发病前即存在视听力障碍、认知功能障碍；（6）有癫痫病史。

1.2 方法

对照组实施言语康复训练，包括：（1）构音发音训练：指导患者通过弹舌、卷舌、鼓腮等方式，强化声带、舌肌。指导患者从元音模仿开始发声，逐渐加入辅音，然后完成单词的发音，并在发音时通过镜子观察自己口型。（2）听觉理解能力训练：为患者播放音频，音频内容主要为对话、故事等，嘱患者注意倾听，并对音频内容予以复述，回答音频相关的问题。（3）口语表达训练：向患者展示图片，嘱患者对图片内容予以描述，逐渐将词语构建为完整的句子。模拟日常生活场景，如问路、购物等，使患者在情境中进行口语表达。（4）阅读理解训练：指导患者从最简单的字、词开始阅读，逐渐过渡至句子短文。（5）书写能力训练：指导患者正确握笔、运笔姿势，从简单笔画开始，循序渐进地进行完整汉字书写，抄写词汇，抄写短语或句子，书写日记训练。每次治疗60分钟，每日治疗1次，每周连续治疗5日。

试验组在对照组基础上，施以深刺纳阳针法：采用一次性无菌针灸针（规格：0.25 mm×75 mm），取廉泉、崇骨、哑门、通里（双侧）、关元穴。廉泉向舌根方向斜刺，哑门向下颌方向斜刺，崇骨向咽喉方向斜刺，其他穴位均为直刺。所有穴位针刺时，医师需将注意力集中于针尖，缓慢进针，感受得气后，再将针尖由浅至深刺入。廉泉最深刺入2寸，崇骨最深刺入2寸，哑门最深刺入1.5寸，通里最深刺入1.5寸，关元最深刺入1.5寸。行平补平泻手法，留针30分钟。每日治疗1次，每周连续治疗5日。见

中国知网 https://www.cnki.net

图 1。

图 1 深刺纳阳针法

两组均治疗 4 周后观察效果。

1.3 观察指标

（1）病情相关评分：采用汉语失语成套评定量表（Aphasia Battery of Chinese，ABC）[8]、功能性语言沟通能力检查法（Chinese Functional Communication Profile，CFCP）[9] 对各组治疗前、后病情程度予以评估。ABC 包含听理解、沟通、命名及复述 4 个维度，量表总分 48 分，得分越低，病情越重。CFCP 包含基础语言功能，非言语沟通，生活场景交流等内容，共 25 个项目，分值范围 0 ～ 250 分，得分越低，病情越重。（2）总体疗效：根据患者治疗后 ABC 评分变化情况评估疗效，显效：4 周疗程结束后，患者 ABC 评分较治疗前下降 60%；有效，4 周疗程结束后，患者 ABC 评分较治疗前下降 30%，但未达到 60%；无效：4 周疗程结束后，患者 ABC 评分较治疗前下降未达 30% 甚至增加。总有效率 = 显效率 + 有效率。（3）认知功能：选择简易智能精神状态检查量表（Mini Mental State Examination，MMSE）[10]、蒙特利尔认知评估量表（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）[11] 评估各组治疗前、后认知功能。MMSE 共 30 个条目，包括注意力、记忆力、语言能力等内容，量表总分 30 分。MoCA 共 11 个条目，包括抽象能力、定向力、执行力等内容，量表总分 30 分。两量表得分越高，认知功能越好。（4）不良反应：观察并记录各组治疗期间所发生的不良反应。

1.4 统计学分析

所得数据录入电脑，以 SPSS22.0 软件分析，计量资料以均数 ± 标准差表示，组间、组内对比分别用独立样本、配对样本 t 检验；计数资料以例（%）表示，组间比较使用 χ^2 检验。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病情相关评分比较

组内不同阶段比较，治疗后 ABC 评分、CFCP 评分均高于治疗前（$P < 0.05$）。治疗后组间比较，试验组 ABC 评分、CFCP 评分均高于对照组（$P < 0.05$）。见表 1。

表 1 两组治疗前、后病情相关评分比较（$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	ABC 评分（分）		CFCP 评分（分）	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组	48	17.94±3.15	29.36±4.51△	135.92±18.57	198.04±24.16△
对照组	48	18.26±3.78	25.12±4.08△	137.45±19.22	173.26±21.85△
t 值		0.451	4.830	0.397	5.270
P 值		0.653	＜ 0.001	0.693	＜ 0.001

注：与本组治疗前比较，△$P < 0.05$

2.2 总体疗效比较

治疗总有效率组间比较，试验组为 93.75%，高于对照组（77.08%）（$P < 0.05$）。见表 2。

表 2 两组总体疗效比较 [例（%）]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
试验组	48	19（39.58）	26（54.17）	3（6.25）	45（93.75）
对照组	48	14（29.17）	23（47.92）	11（22.92）	37（77.08）
χ^2 值					5.352
P 值					0.021

2.3 认知功能比较

组内不同阶段比较，治疗后 MMSE 评分、MoCA 评分均高于治疗前（P 均＜ 0.05）。治疗后组间比较，试验组治疗后 MMSE 评分、MoCA 评分均高于对照组（P 均＜ 0.05）。见表 3。

表 3 两组治疗前、后认知功能比较（$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	MMSE 评分（分）		MoCA 评分（分）	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组	48	24.68 ± 2.37	27.83 ± 2.05△	23.84 ± 2.53	27.42 ± 2.19△
对照组	48	24.91 ± 2.40	26.51 ± 2.27△	24.01 ± 2.63	26.18 ± 2.36△
t 值		0.472	2.990	0.323	2.668
P 值		0.638	0.004	0.748	0.009

注：与本组治疗前比较，△$P < 0.05$

2.4 不良反应比较

不良反应发生率组间比较，试验组为 8.33% 与对照组（4.17%），无明显差异（$P > 0.05$）。见表 4。

表 4 两组用药安全性比较 [例（%）]

组别	例数	皮下淤青	头痛	滞针	总计
试验组	48	1（2.08）	1（2.08）	2（4.17）	4（8.33）
对照组	48	0	2（4.17）	0	2（4.17）
χ^2 值					0.711
P 值					0.399

3 讨论

卒中是一种高发且高危的脑血管疾病，发病后由于脑组织处于血氧供给缺乏状态，导致神经功能受损，从而引发一系列并发症。失语在卒中恢复期患者中较为常见，研究认为，卒中后失语发生的核

中国知网 https://www.cnki.net

心机制是神经元及胶质细胞凋亡，导致神经传导通路异常，语言中枢遭受损害[12]。卒中后失语主要表现为语调及发音异常、表达障碍、语言理解能力下降、书写能力也会受到影响，对患者后续生活、康复有较大干扰。言语康复训练是当前治疗卒中后失语的主要方法，通过针对性地实施构音发音，听觉理解，口语表达等训练，可对受损语言区周围神经元产生刺激作用，有利于神经重塑，并能激活功能代偿机制，加快语言恢复。同时言语康复训练还能改善发音肌群的协调性[13]。但仅实施言语康复训练存在一定局限性，部分患者效果不理想。随着中医重要性的日益凸显，为卒中患者并发症的治疗提供了更多思路。如何应用中医疗法更好治疗卒中后失语，是临床研究重点。

卒中后失语在中医理论属于“喑俳”范畴，如《圣济总录》中便有“喑俳之状、舌喑不能语、盖肾脉络舌本、肾气内夺、气厥不至舌本，故不能语而为喑”之记载。中医认为，阳虚是该病发生的主要病机，《素问》云“阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通”。患者中风后，机体阴阳失衡，阳气虚衰，窍道失于温煦，进而壅塞不通，舌体无以濡养而失用，终致喑俳。基于患者病机特点，本研究采用深刺纳阳针法治疗，该针法由我院学科带头人张智龙教授所创。张教授认为以针刺治疗阳虚所致窍位不通时，应遵循“从阴引阳，从阳引阴”之原则，达到深纳阳气、疏利阴分之作用[14]。深刺纳阳针法取阳位之穴，先刺入浅表，得气后再推进，由浅入深，引浅层阳气至阴分，从而达到纳阳和阴，温煦窍道，濡养舌体之目的。本研究所取廉泉为任脉要穴，有舒利喉舌之效。崇骨属经外奇穴，其在督脉循行，刺之能引阳气入里，达于阴分。哑门属督脉，具有通阳开窍，通络醒脑功效。通里属手少阴心经，能通舌络，调心神。关元穴为任脉与足三阴交会之穴，具有温阳固脱，补益元气之效。针刺治疗能对咽喉肌群、舌骨上肌群的收缩协调能力予以改善，有利于减轻构音障碍。同时刺激信号传入中枢神经后，能对脑干网状结构产生调节作用，从而促进语言相关神经的重塑[15]。

本研究以深刺纳阳针法联合言语康复训练对卒中后失语予以治疗，4 周疗程结束后，试验组 ABC 评分、CFCP 评分明显高于对照组，且试验组总有效率为 93.75% 高于对照组。表明该方案能显著改善失语病情，起到协同增效作用。有学者认为，卒中后失语会对患者认知功能造成影响，导致记忆力、注意力障碍[16]。本研究中，试验组治疗后 MMSE 评分、MoCA 评分较对照组有更明显提升，表明深刺纳阳针法联合言语康复训练在改善卒中后失语患者认知功能方面有确切作用。在开展言语康复训练时，个别患者出现紧张性头痛，休息后可恢复。少数患者针刺治疗时出现滞针及轻度皮下淤青，轻揉施针部位肌肉可解除滞针，皮下淤青可自行消除。两组不良反应发生率均较低且无明显差异，未观察到严重不良反应，表明刺纳阳针法联合言语康复训练是安全治疗方案。

综上所述，对卒中后失语患者实施深刺纳阳针法联合言语康复训练，能促进病情转归，增强治疗效果，并能改善认知功能，且安全性良好。

参考文献

[1] 中华医学会神经病学分会神经康复学组，中国康复医学会脑血管病专业委员会，中国康复研究中心 . 卒中后失语临床管理专家共识[J]. 中国康复理论与实践，2022，28（1）：15-23.

[2] 朱巍明，李波漩，邓士哲，等 . 不同针刺法联合言语训练治疗卒中后失语的网状 Meta 分析 [J]. 世界中医药，2024，19（3）：347-355.

[3] 李飞跃，郭铁，孙道东，等 . 针刺治疗卒中后失语症的 MRS 研究进展 [J]. 中国中西医结合影 像学杂志，2024，22（5）：622-626，630.

[4] 杨同瑞，吉学群 . 基于“从卫取气，从营置气”理论探讨深刺纳阳针法的作用机理 [J]. 四川中医，2023，41（8）：60-62.

[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国脑出血诊治指南（2019）[J]. 中华神经科杂志，2019，52（12）：994-1005.

[6] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国急性缺血性卒中诊治指南 2023[J]. 中华神经科杂志，2024，57（6）：523-559.

[7] 汉语失语症康复治疗专家共识组 . 汉语失语症康复治疗专家共识 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2019，41（3）：161-169.

[8] 付婧，张海平，余茜，等 . 自编简易临床失语量表的信度和效度验证 [J]. 重庆医科大学学报，2021，46（11）：1320-1323.

[9] 王小荣 . 功能性语言沟通能力检查法在脑血管意外后失语症患者中应用价值的初步研究 [D]. 中山大学，1991.

[10] 周小炫，谢敏，陶静，等 . 简易智能精神状态检查量表的研究和应用 [J]. 中国康复医学杂志，2016，31（6）：694-696，706.

[11] 陈南星，刘婷，蔡奔，等 . 卒中版蒙特利尔认知评估量表的开发及测评 [J]. 蚌埠医学院学报，2020，45（2）：267-270.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] 于晓辉，梁志刚. 脑卒中后失语症治疗的研究进展 [J]. 医学综述，2021，27（3）：513-518.

[13] 刘雪云，柯俊，李坦，等. 卒中后失语症语言康复机制和治疗研究进展 [J]. 中国康复理论与实践，2018，24（8）：884-888.

[14] 张智龙. 深刺纳阳针法的理论与应用 [J]. 中华针灸电子杂志，2024，13（1）：5-6.

[15] 李昭缘，张建忠，张思聪，等. 针刺治疗脑卒中后失语症的研究进展 [J]. 西部中医　药，2023，36（6）：149-152.

[16] Seo K C， Ko J Y， Kim T U，et al.Post-stroke Aphasia as a Prognostic Factor for Cognitive and Functional Changes in Patients With Stroke：Ischemic Versus Hemorrhagic[J].Annals of Rehabilitation Medicine，2020，44（3）：171-180.

（本文编辑：张玉超 左丹）

中国知网 https://www.cnki.net